FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA

SOMATOPSÍQUICA

Aula 4

Corporificação e Remapeamento

Quando a experiência se transforma em aprendizagem

FASE 1 - HABITAR O CORPO

Guia de apoio à aula e à prática da semana

Corporificação, propriocepção, mapeamento, agência e remapeamento.

Dra. Renata Guerra

Retome este material junto ao Diário de Prática Somatopsíquica.

A PERGUNTA QUE ABRE A AULA

Compreender significa já ter conseguido experimentar?

Conhecimento é necessário, mas nem sempre modifica uma resposta incorporada.

Compreender

Organizar, explicar e relacionar ajudam a construir sentido. Essa forma de conhecimento é indispensável, mas pode permanecer distante da experiência vivida.

Corporificar

Sentir, diferenciar e integrar permitem reconhecer como uma experiência se apresenta no corpo, nas emoções, nos pensamentos e no movimento.

Corporificar não significa sentir com maior intensidade. Significa ampliar contato, diferenciação e integração.

O que, nesta aula, deixou de ser apenas uma ideia e passou a ser reconhecido na sua experiência?

CORPORIFICAÇÃO

Integração das dimensões da experiência

Na IPS, corporificação descreve a possibilidade de reconhecer e integrar diferentes dimensões do que está sendo vivido. Não se trata de permanecer continuamente atento ao corpo nem de buscar sensações intensas.

DIMENSÃO	PERGUNTA CLÍNICA
Corpo - sensações, postura e apoios	Como a experiência se apresenta fisicamente agora?
Emoções - tonalidade afetiva	Há alguma emoção associada ao que está sendo percebido?
Pensamentos - narrativa e significado	Algum pensamento, lembrança ou interpretação acompanha a experiência?
Movimento - resposta possível	O corpo reconhece alguma necessidade ou possibilidade de movimento?

O corpo não substitui o pensamento. A corporificação amplia as informações disponíveis para compreender e responder.

Na prática clínica

A linguagem vem depois do contato. Nomear pode ajudar a organizar, diferenciar, memorizar e comunicar a experiência sem reduzir o vivido a uma explicação precoce.

SENSIBILIDADE CORPORAL

Interocepção e propriocepção

A experiência corporal depende de diferentes sistemas sensoriais que trabalham de forma integrada.

INTEROCEPÇÃO	PROPRIOCEPÇÃO
Percepção e integração de sinais relacionados ao estado interno do organismo.	Percepção da posição, do movimento e da força do corpo.
Pode incluir respiração, batimentos, temperatura, tensão, fome ou desconforto.	Informa onde o corpo está, como sustenta o peso e como se move no espaço.
Contribui para a percepção do estado corporal e para a regulação.	Contribui para postura, equilíbrio, coordenação e senso de ação.

Na IPS

Grounding, mapeamento e movimento mobilizam informações interoceptivas e proprioceptivas. A pessoa reconhece apoios, posição, tensão, movimento e possíveis alterações após a agência somatopsíquica.

Corporificação não se reduz à interocepção. Ela integra corpo, emoção, pensamento, movimento, contexto e significado.

A hipótese do marcador somático

Damásio propôs que sinais relacionados a estados corporais e emocionais podem influenciar a avaliação de possibilidades e favorecer ou inibir determinadas escolhas.

O papel central do CPFVM

Na formulação original, o setor ventromedial do córtex pré-frontal ocupa posição crítica. Ele participa da integração entre experiências anteriores, consequências previstas e estados somáticos associados.

CPFVM e córtex orbitofrontal

Os termos não são sinônimos. Existe sobreposição entre regiões ventromediais e orbitomediais, e as lesões históricas frequentemente alcançavam ambos os territórios. Por isso, a literatura por vezes utiliza vmPFC, OFC ou vmPFC/OFC. Essa variação não autoriza atribuir a mesma função a todo o córtex orbitofrontal.

A hipótese é um modelo influente para pensar emoção e decisão. Ela não deve ser apresentada como uma cadeia causal definitivamente comprovada.

Aplicação criteriosa na IPS

A IPS reconhece o valor clínico de incluir informações corporais na tomada de decisão, sem afirmar que uma sensação isolada determina automaticamente a escolha correta.

O QUE OS ESTUDOS MOSTRAM

Evidências compatíveis e limites

Northoff et al. (2006)

Participantes saudáveis realizaram julgamentos afetivos durante a fMRI e, em outra etapa, o Iowa Gambling Task. Maior recrutamento do CPFVM em julgamentos afetivos inesperados associou-se ao desempenho global e final no IGT. A fMRI não ocorreu durante o IGT; o achado é associativo e indireto.

Zha et al. (2022)

Cinquenta e quatro adultos saudáveis realizaram o IGT durante a fMRI. Padrões de atividade do córtex orbitofrontal distinguiram escolhas vantajosas e desvantajosas, e a precisão se associou à aprendizagem e ao desempenho. O estudo avaliou representação da escolha, não sinais corporais ou marcadores somáticos.

Dunn, Dalgleish e Lawrence (2006)

A revisão crítica reconheceu evidências compatíveis com a hipótese, mas destacou explicações cognitivas alternativas, inespecificidade das respostas fisiológicas e ausência de demonstração direta de toda a cadeia causal.

Zha amplia a compreensão das redes neurais da decisão, mas não testa diretamente a hipótese do marcador somático.

MAPEAMENTO SOMATOPSÍQUICO

Da sensação à experiência diferenciada

O mapeamento começa pelo corpo e avança progressivamente. A ordem protege o contato com a experiência antes que uma interpretação cognitiva precoce determine aquilo que a pessoa acredita que deveria sentir.

1. Sensação e características

Localização, intensidade, distribuição, tamanho, forma, limites, cor, textura, temperatura, peso, movimento, direção, profundidade e eventual som associado. As perguntas são convites, não um questionário mecânico.

2. Emoção associada

Depois da caracterização corporal: há alguma emoção associada a essa experiência? A pessoa pode reconhecer uma emoção, ter dúvida ou não encontrar uma palavra.

3. Pensamento associado

Em seguida: há algum pensamento associado a esse momento? Pode surgir uma frase, preocupação, previsão, cobrança, lembrança ou interpretação.

Primeiro o corpo é percebido. Depois a sensação é caracterizada. Em seguida reconhecemos emoção e pensamento.

O movimento produz informação

A agência somatopsíquica é a ponte funcional entre o primeiro mapeamento e o remapeamento. A pessoa deixa o corpo movimentar-se de forma espontânea, criativa e suficientemente lenta para acompanhar a experiência.

O movimento

Não existe um movimento certo. O facilitador convida a pessoa a reconhecer uma necessidade corporal e permitir que o movimento se desenvolva dentro de seus limites e com autorresponsabilidade.

O remapeamento

Depois da agência, a pessoa percorre novamente o corpo e observa se localização, cor, forma, textura, temperatura, profundidade, emoção ou pensamento permaneceram iguais ou se modificaram.

PRIMEIRO MAPEAMENTO	REMAPEAMENTO
Como a experiência se apresenta antes do movimento?	Como a experiência se apresenta depois do movimento?
Registra o estado inicial sem exigir mudança.	Reconhece efeitos, permanências e diferenças.

O remapeamento não existe para provar melhora. Ele permite reconhecer o que aconteceu depois da própria ação.

SINAIS CLÍNICOS

Quando apoiar e diminuir o ritmo

Possíveis sinais de pouca corporificação

- Explicação extensa com pouca percepção da experiência atual.
- Sensações globais, vagas ou difíceis de diferenciar.
- Movimento executado sem reconhecimento dos efeitos.
- Busca imediata por alívio ou pela resposta considerada correta.

Esses sinais não indicam falha

Eles mostram onde o facilitador pode reduzir a velocidade, apoiar a discriminação e retornar às condições de presença e segurança.

Condutas possíveis

- Orientar ao ambiente e reconhecer os apoios.
- Reduzir a intensidade ou o tamanho do movimento.
- Confirmar escolha e possibilidade de interromper.
- Permanecer no grounding quando o contato diminui.

Corporificação deve ser convidada, nunca exigida.

PRÁTICA DA AULA

Os 7 passos completos da IPS

Escolha uma situação cotidiana de intensidade leve ou moderada que você deseje corporificar.

Não é necessário acessar a experiência mais difícil. A pessoa pode abrir os olhos, diminuir o ritmo ou interromper. A vivência percorre os 7 passos completos, no modo transformação.

PASSO	FOCO DA EXPERIÊNCIA
1. Presença e enraizamento	Chegar ao aqui e agora, reconhecer pés, apoios, sustentação e respiração.
2. Mapeamento somatopsíquico	Reconhecer corpo, sensação, emoção e pensamento associados à situação.
3. Agência somatopsíquica	Permitir movimento espontâneo, criativo e acompanhado pela atenção.
4. Remapeamento	Perceber o que permaneceu e o que mudou depois do movimento.
5. Insight	Abrir espaço para uma informação, imagem, palavra, frase ou sensação.
6. Atenção plena	Permanecer em silêncio meditativo e integrar a experiência sem julgamento.
7. Fechamento	Relacionar a experiência e o insight ao ponto trazido para a prática.

PRÁTICA DA SEMANA

Antes e depois

Escolha situações leves ou moderadas e registre a experiência no Diário de Prática Somatopsíquica. A proposta não é produzir uma resposta ideal, mas reconhecer com maior precisão o percurso vivido.

Antes

Como a situação aparecia no corpo? Quais sensações, emoção e pensamento estavam associados?

Movimento

Que movimento surgiu? Como foi permitir, acompanhar ou sustentar esse movimento?

Depois

O que permaneceu? O que mudou? Como a emoção e o pensamento se apresentam agora?

DO ARTIGO AO CONSULTÓRIO

Tradução clínica responsável

A EVIDÊNCIA SUSTENTA	A EVIDÊNCIA NÃO AUTORIZA
A participação de processos corporais, afetivos e valorativos na decisão.	Afirmar que uma sensação corporal isolada revela a decisão correta.
A relevância do CPFVM em integração afetiva e escolhas baseadas na experiência.	Tratar CPFVM e todo o córtex orbitofrontal como estruturas equivalentes.
A participação do OFC na representação de valor e escolha.	Usar o estudo de Zha como comprovação de marcadores somáticos.
O uso clínico do antes e depois para ampliar diferenciação e aprendizagem.	Exigir mudança ou interpretar ausência de mudança como fracasso.

Perguntas para médicos e psicólogos em formação

- Estou ajudando a pessoa a perceber ou oferecendo uma interpretação pronta?
- Estou preservando escolha, segurança e possibilidade de interrupção?
- O remapeamento reconhece a experiência real ou busca confirmar uma expectativa?
- Consigo diferenciar uma hipótese clínica de uma conclusão científica?

Na IPS, rigor científico e experiência corporal precisam caminhar juntos.

BIBLIOTECA SOMATOPSÍQUICA

Referências essenciais

Damasio AR. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. New York: Putnam; 1994.

Damasio AR. The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1996;351(1346):1413-1420. doi:10.1098/rstb.1996.0125.

Bechara A, Damasio H, Damasio AR, Lee GP. Different contributions of the human amygdala and ventromedial prefrontal cortex to decision-making. J Neurosci. 1999;19(13):5473-5481. doi:10.1523/JNEUROSCI.19-13-05473.1999.

Dunn BD, Dalgleish T, Lawrence AD. The somatic marker hypothesis: a critical evaluation. Neurosci Biobehav Rev. 2006;30(2):239-271. doi:10.1016/j.neubiorev.2005.07.001.

Northoff G, Grimm S, Boeker H, et al. Affective judgment and beneficial decision making: ventromedial prefrontal activity correlates with performance in the Iowa Gambling Task. Hum Brain Mapp. 2006;27(7):572-587. doi:10.1002/hbm.20202.

Farb NAS, Daubenmier J, Price CJ, et al. Interoception, contemplative practice, and health. Front Psychol. 2015;6:763. doi:10.3389/fpsyg.2015.00763.

Mehling WE, Acree M, Stewart A, et al. The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness, Version 2 (MAIA-2). PLoS One. 2018;13(12):e0208034. doi:10.1371/journal.pone.0208034.

Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. Physiol Rev. 2012;92(4):1651-1697. doi:10.1152/physrev.00048.2011.

Zha R, Li P, Liu Y, et al. The orbitofrontal cortex represents advantageous choice in the Iowa gambling task. Hum Brain Mapp. 2022;43(12):3840-3856. doi:10.1002/hbm.25887.

Material de apoio à Formação em Psiquiatria Somatopsíquica. Utilize junto à aula gravada, ao Diário de Prática e ao Roteiro dos 7 Passos da IPS.